Bronquiolite Viral Aguda
Material de estudo – Letícia

Semiologia e Semiotécnica · Foco: diagnóstico, tratamento e anotação de enfermagem

1. Resumo objetivo da doença

Tópico	O essencial
O que é	Infecção viral aguda que inflama os bronquíolos (vias aéreas com menos de 2 mm).
Quem pega	Crianças menores de 2 anos; mais grave em menores de 6 meses, prematuros, cardiopatas e com doença pulmonar crônica.
Causa	VSR (vírus sincicial respiratório) em até 75% dos casos. Outros: rinovírus, metapneumovírus, adenovírus, parainfluenza, influenza.
Transmissão	Gotículas, contato direto com secreções e superfícies. VSR dura menos de 1 h nas mãos e até cerca de 24 h em superfícies duras.
Incubação	4 a 5 dias.
Época	Sudeste: março a julho (SBP). MG: pico recente de fevereiro a abril (SES-MG).
O que acontece	Edema da parede + muco + restos de células = obstrução do bronquíolo, ar preso e queda da oxigenação.
Evolução	Começa como resfriado (dias 1–3), piora entre o 3º e o 5º dia e melhora em 7 a 10 dias; a tosse pode durar mais.
Prevenção no SUS	Vacina VSR para gestantes a partir da 28ª semana; nirsevimabe para prematuros e menores de 2 anos com comorbidades.

Frase para lembrar: bronquite atinge os brônquios (galhos grossos); bronquiolite atinge os bronquíolos (galhos finos). Como o bebê tem vias aéreas muito estreitas e respira quase só pelo nariz, qualquer inchaço ou muco já dificulta respirar e mamar.

2. Diagnóstico (aprofundado)

2.1 O diagnóstico é clínico

A SBP (2017) afirma que o diagnóstico da bronquiolite é principalmente clínico: baseia-se na história (idade, início com resfriado, contato com pessoas gripadas, época do ano) e no exame físico. Não existe um exame que "confirme" a bronquiolite sozinho.

2.2 O que se observa no exame físico

- **Inspeção:** coriza, tosse, respiração rápida, tiragem (subcostal, intercostal, de fúrcula), batimento de asa de nariz, cianose.
- **Contagem da frequência respiratória:** sempre por 1 minuto inteiro, com o bebê calmo, de preferência dormindo.
- **Ausculta (feita pelo médico/enfermeiro):** sibilos (chiado) e crepitações (estertores finos).

- **Estado geral:** ativo e reativo × hipoativo ou prostrado; aceitação das mamadas; diurese.

2.3 Exames complementares: quando usar

Exame	Uso na bronquiolite
Oximetria de pulso	Mede a SpO_2. Uso intermitente na fase aguda dos internados; o uso contínuo de rotina foi associado a internações mais longas (SBP).
Pesquisa viral (painel/teste rápido)	Não muda o tratamento, mas ajuda o hospital a organizar o isolamento (coorte) dos pacientes.
Raio-X de tórax	Não é rotina. Só se houver dúvida diagnóstica ou suspeita de complicação (AAP, 2014).
Exames de sangue	Não são rotina. Considerados em casos graves ou com suspeita de infecção bacteriana.

2.4 Sinais de gravidade e critérios de internação (SBP, 2017)

- Episódios de apneia (pausas na respiração).
- Piora do estado geral: hipoativo, prostrado, acorda apenas com estímulos prolongados.
- Desconforto respiratório: gemência, retração torácica, FR acima de 60, cianose central, saturação abaixo de 92% persistente.
- Sinais de desidratação.
- Recusa alimentar, ingestão reduzida e/ou sem diurese por 12 horas.
- Comorbidades: displasia broncopulmonar, cardiopatia, imunodeficiência, doença neuromuscular.

Papel do técnico de enfermagem no diagnóstico: o técnico não faz o diagnóstico, mas é quem mais observa o paciente. Identificar e comunicar rapidamente esses sinais faz parte da avaliação contínua e pode mudar a conduta médica.

3. Tratamento (aprofundado)

3.1 Princípio

Não há terapêutica específica que abrevie o curso da doença: o tratamento é de suporte, e a maioria dos pacientes evolui bem (SBP, 2017). O objetivo é manter o bebê hidratado, com as vias aéreas desobstruídas e bem oxigenado enquanto o próprio organismo vence o vírus.

3.2 O que a diretriz recomenda ou permite considerar

Medida	Como funciona / quando
Hidratação	Manter amamentação. Se não conseguir por via oral: sonda nasogástrica ou soro na veia (solução isotônica). Estudo com 759 lactentes não mostrou diferença entre sonda e veia; a sonda é mais acessível.

Higiene nasal	Soro fisiológico 0,9% antes das mamadas. Lavagem nasal sem aspiração já melhora a saturação.
Aspiração nasal	Suave e superficial, só quando necessária. Aspiração profunda ou repetida pode irritar a mucosa e prolongar a internação.
Oxigênio	Não indicado com SpO_2 acima de 90% sem acidose. Considerar entre 90 e 92%, especialmente com esforço respiratório e menores de 3 meses. Sempre conforme prescrição.
Salina hipertônica 3%	Pode ser considerada em internados (mais de 3 dias), por decisão médica, por nebulização.
Cânula nasal de alto fluxo	Pode ser considerada em casos mais graves, em ambiente hospitalar.
Antitérmico	Se necessário, conforme prescrição.

3.3 O que NÃO é recomendado (e por quê)

Tratamento	Motivo
Broncodilatador (ex.: salbutamol)	Estudos não mostraram melhora dos sintomas, da taxa de internação nem do tempo de internação. Na bronquiolite a obstrução é por edema e muco, não por contração do músculo como na asma.
Adrenalina	Sem benefício comprovado em pacientes ambulatoriais ou internados.
Corticoide	Ensaios grandes e multicêntricos sem benefício.
Antibiótico	A doença é viral; o uso rotineiro não reduz dias de sintomas, internação ou necessidade de O_2. Só se houver infecção bacteriana associada.
Fisioterapia respiratória de rotina	Não recomendada; reservada para casos com comorbidades.
Névoa / vaporizador	Sem benefício; vaporizador quente ainda traz risco de queimadura.

3.4 Tratamento em casa (orientação aos cuidadores)

- Higiene das mãos com água e sabão ou álcool 70%.
- Evitar fumaça de cigarro (tabagismo passivo).
- Manter alimentação e amamentação, oferecendo em volumes menores e mais vezes.
- Lavagem nasal com soro fisiológico, principalmente antes de mamar e dormir.
- Antitérmico apenas se necessário e prescrito; nenhum xarope ou remédio sem receita.
- Voltar imediatamente ao serviço se aparecer qualquer sinal de alarme.

3.5 Cuidados de enfermagem no paciente internado

- Monitorar FC, FR (1 minuto), SpO_2, temperatura e padrão respiratório; registrar com horário.

- Higiene nasal com SF 0,9% antes das mamadas; aspiração suave só se necessária; registrar aspecto e quantidade da secreção.
- Instalar e manter oxigênio conforme prescrição, checando a adaptação do dispositivo (cateter, máscara) e a umidificação.
- Controle de aceitação alimentar e balanço hídrico: pesar fraldas (1 g ≈ 1 mL de urina).
- Cabeceira elevada a 30°; agrupar os cuidados para o bebê descansar; ambiente tranquilo.
- Precaução de contato e gotículas; higiene das mãos nos 5 momentos.
- Orientar a mãe/acompanhante; comunicar imediatamente sinais de agravamento à enfermeira.

4. Anotação de enfermagem (aprofundado)

4.1 O que é e para que serve

É o registro escrito, feito pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, de tudo o que foi observado e realizado com o paciente. É um documento legal: comprova a assistência, garante a continuidade do cuidado entre os plantões e protege o profissional. O que não está anotado, para fins legais, não foi feito.

Diferença importante: a anotação de enfermagem (técnico/auxiliar) descreve dados observados e cuidados realizados. A evolução de enfermagem é privativa do enfermeiro e envolve análise e julgamento clínico.

4.2 Regras de ouro

- Sempre com **data e hora** de cada registro.
- Linguagem **objetiva**, clara, sem abreviações não padronizadas e sem julgamentos ("mãe nervosa" → "mãe chorosa, questiona sobre o estado do filho").
- Registrar **o que viu, o que fez e o resultado** (ex.: "realizada higiene nasal, com saída de secreção espessa em moderada quantidade").
- Não usar termos vagos como "bem", "normal", "sem alterações" sem descrever.
- Letra legível, caneta, **sem rasuras**, sem corretivo e sem deixar linhas em branco; se errar, escrever "digo" e continuar.
- Terminar com **nome completo, categoria e COREN**.
- Não registrar diagnóstico médico como se fosse conclusão própria; usar "com diagnóstico médico de...".

4.3 Roteiro (ordem sugerida)

Parte	O que escrever no caso de bronquiolite
Identificação	Data, hora, iniciais, idade, setor, leito, procedência, acompanhante.
Estado geral	Nível de consciência e atividade (ativo e reativo, choroso, hipoativo).
Respiratório	Padrão (taquipneico?), tiragem (onde, intensidade), batimento de asa de nariz, gemência, coriza, tosse, uso de O_2 (dispositivo e litros).

Sinais vitais	T, FC, FR, SpO_2 (em ar ambiente ou com O_2), PA; peso na admissão.
Procedimentos	Higiene nasal, aspiração (aspecto e quantidade), posicionamento, medicações administradas conforme prescrição.
Alimentação e eliminações	Aceitação das mamadas, vômitos, diurese (peso da fralda), evacuação.
Orientações e comunicação	O que foi orientado à mãe; a quem foi comunicada alguma alteração.
Assinatura	Nome, categoria, COREN.

4.4 Modelo 1 – Admissão (usado no slide)

02/11/2026, 14h30. Lactente M.H.S., 5 meses, admitido na enfermaria pediátrica, leito 08, procedente do PS pediátrico, acompanhado pela mãe, com diagnóstico médico de bronquiolite viral aguda. Encontra-se choroso, ativo e reativo. Apresenta coriza hialina, tosse produtiva e tiragem subcostal leve. SSVV: T 37,8 °C, FC 148 bpm, FR 56 irpm, SpO_2 93% em ar ambiente, PA 85/50 mmHg. Peso: 6,8 kg. Realizada higiene nasal com SF 0,9%, com saída de secreção espessa em moderada quantidade. Mantido em decúbito dorsal com cabeceira elevada a 30°. Instaladas precauções de contato e gotículas. Mãe orientada quanto à higiene das mãos. Oferecido seio materno, com aceitação parcial. Diurese presente em fralda (45 g). Comunicado à enfermeira. Nome, Técnico(a) de Enfermagem, COREN-MG nº ____.

4.5 Modelo 2 – Intercorrência (piora)

02/11/2026, 20h10. Lactente apresentando aumento do esforço respiratório, com tiragem subcostal e intercostal moderada e batimento de asa de nariz. FR 68 irpm, FC 165 bpm, SpO_2 89% em ar ambiente. Realizada aspiração nasal suave, com saída de secreção espessa em grande quantidade. Mantido com cabeceira elevada a 30°. Comunicado imediatamente à enfermeira e ao médico plantonista. Instalado cateter nasal de O_2 a 1 L/min conforme prescrição. Após 15 minutos, SpO_2 95%. Mantido em observação. Nome, Técnico(a) de Enfermagem, COREN-MG nº ____.

Este segundo modelo é um exemplo didático para mostrar à banca como registrar uma piora: sinal observado → valor medido → ação → comunicação → resultado.

4.6 Siglas que aparecem na anotação

Sigla	Significado
SSVV	Sinais vitais
T	Temperatura (axilar)
FC / bpm	Frequência cardíaca / batimentos por minuto
FR / irpm	Frequência respiratória / incursões respiratórias por minuto
SpO_2	Saturação periférica de oxigênio
PA	Pressão arterial
SF 0,9%	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%)

PS	Pronto-socorro
Coriza hialina	Secreção nasal clara, transparente
Ativo e reativo	Bebê se movimenta e responde a estímulos

5. Perguntas que a banca pode fazer

P: Por que não se usa broncodilatador na bronquiolite?

R: Porque estudos não mostraram benefício. A obstrução é causada por edema, muco e restos celulares, e não por contração do músculo como na asma.

P: O raio-X é necessário para diagnosticar?

R: Não. O diagnóstico é clínico. O raio-X só é feito se houver dúvida ou suspeita de complicação.

P: Quando o bebê precisa de oxigênio?

R: Quando a saturação fica abaixo de 90 a 92%, conforme prescrição. Acima de 90% sem acidose, a SBP não recomenda.

P: Qual a diferença entre anotação e evolução de enfermagem?

R: A anotação é feita pelo técnico/auxiliar e registra o que foi observado e realizado. A evolução é privativa do enfermeiro e inclui análise e julgamento clínico.

P: Por que no caso do Miguel ele não está no oxigênio?

R: Porque a saturação dele é de 93% em ar ambiente, acima do ponto em que a diretriz indica O_2. Mas ele deve ser monitorado, pois pode piorar entre o 3º e o 5º dia.

P: Se você errar algo na anotação, o que faz?

R: Não rasura nem usa corretivo: escreve "digo" e corrige em seguida, mantendo o registro legível.

P: Como medir a diurese de um bebê?

R: Pesando a fralda usada e subtraindo o peso da fralda seca: cada grama corresponde a cerca de 1 mL de urina.

6. Checklist de revisão

- ☐ Explicar em uma frase o que é bronquiolite e o agente principal.
- ☐ Listar 6 sinais de alarme com os valores (FR acima de 60, SpO_2 abaixo de 92%).
- ☐ Explicar por que o diagnóstico é clínico e quando pedir raio-X.
- ☐ Saber 4 tratamentos recomendados e 4 não recomendados, com o motivo.
- ☐ Ler os dois modelos de anotação em voz alta sem tropeçar nas siglas.
- ☐ Saber a diferença entre anotação (técnico) e evolução (enfermeiro).

7. Fontes

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – 2017**. Rio de Janeiro: SBP, 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20277e-Diretrizes_VSR.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

RALSTON, S. L. *et al*. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. **Pediatrics**, Itasca, v. 134, n. 5, p. e1474-e1502, nov. 2014. DOI: 10.1542/peds.2014-2742.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **Contra a bronquiolite: regional de Montes Claros alinha com maternidades uso de imunobiológico em bebês e crianças**. Belo Horizonte: SES-MG, 10 fev. 2026. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/noticias/contra-a-bronquiolite-regional-de-montes-claros-alinha-com-maternidades-uso-de-imunobiologico-em-bebes-e-criancas/. Acesso em: 4 nov. 2026.